

안이비 10주차 써머리

01 비과학 총론

제 1장) 코의 구조와 기능

상부 호흡기의 일부로 후각작용, 호흡작용, 성음공명 작용을 하는 감각기관

상부 1/3: 골, 하부 2/3: 연골

外鼻(external nose)

鼻腔(nasal cavity)

副鼻腔(paranasal sinuses)

1. 外鼻(external nose)

- 안면의 중앙부. 삼각추체형, 陵形.
- 부위: 전두골에서 시작. 鼻根, 鼻背, 鼻尖, 鼻翼, 비중격, 인중선, 비순구(法令)로 구분
- 1. 不動部(골부): 좌우의 비골과 전두골 鼻部, 상악골 전두돌기 등
- 2. 可動部(연골부): 비첨에 연장되어 대,소 비익연골이 외비공을 둘러쌌. 측비연골, 비중격연골.
- 피부
- 1. 비골부에서는 얇게, 비첨과 비익의 연골부에서는 두껍고 강하게 결합
- 2. 피부와 연골 사이에 천근건막체계(SMAS) 구성. 주요 혈관 및 신경이 지나감. 수술 시 지방층 아래로 수술 시행
- 신경: 안면신경(운동), 삼차신경 1지 안신경(지각)
- 혈관: 안면동맥, 眼動脈의 분지

2. 鼻腔(nasal cavity)

- 6면 상자 형태. 전벽(외비), 후벽(접형골의 골벽하부). 전방(외비공, 외계), 후방(후비공, 비인두), 상방(사골 사판), 하방(전 2/3 상악골 구개돌기, 후 1/3 구개골 구개판)

1) 비전정

- 외비공의 약 1cm 부위. 측비연골 하단. 안쪽에 鼻毛, 피지선, 한선 등
- 鼻域(limen nasi): 측벽에 융기된 곳. 피부로 덮인 비전정과 점막으로 덮인 고유 비강의 경계

2) 비중격

- 좌우비강 경계를 이루는 중앙벽

*코감기·비염 등에서 한쪽부터 코가 막히는 증상: 비중격만곡증 의심

(수업 때 다룬 내용은 아님) ★ 비중격만곡증 수술은 비중격 발육이 완성되는 ()세 이후에 시행한다. (13) 답: 만 17세

- 1) 전방 연골부: 비중격연골(사각연골). 한쪽으로 만곡 다발
- 2) 후상하방: 후상방(사골수직판), 후하방(서골, 맹관)
- 3) 저부: 구개골의 전비극이 비중격연골과 서골 사이 끼임
- 4) 전상후방 : 전상방(비중격 결절의 점막융기) , 전하방(Little's area , 혹은 Kiesselbach's plexus 앞끝에서 약 5~10mm부위, 비출혈과 밀접)

★ 비강 전방부에서 거리에 있는 코피 호발부위는? (12)

*Little's area: 비중격 전하방 부위 - 코피 자주 생김.

- 비판막: 상외측비연골 하단부와 비중격사이 단면적이 가장 좁은 부위. 이들이 이루는 각을 비판막각(평균 10~15도). 공기를 들이마실때 코막힘 심하다.

->비판막각이 작으면 코의 구조는 멀쩡해도 코가 막힌다고 할 수 있다.

☞ 비판막각(valve angle): 보통 10~15도, 이보다 좁아지면 호흡곤란이 찾아올 수 있음. 성형수술 시 코를 높일 때 이 각도를 고려하지 않으면 환자가 호흡곤란 호소할 수도!

3) 비강상벽

- 鼻骨部. 비공에서 후비강에 이르는 폭 1~3mm 아치형의 좁은 벽

1) 전하방: 비골과 전두골 鼻部 내면

2) 중앙부: 사판, 후신경이 嗅部 형성

3) 후하방: 접형동의 전벽, 서골의, 구개골의 접형돌기, 접형골의 초상돌기; 얇기 때문에 외상에 쉽게 골절 형성)

4) 비강저

- 전후로 수평, 좌우로 약간 오목함
- 전방 3/4(상악골 구개돌기), 후방 1/4(구개골의 수평판). 그 뒤로 연구개가 이어짐
- 切齒管(incisive canal): 상악골 구개돌기의 전단부 약 12mm. 비구개신경의 분지 및 대구개동맥의 분지 등이 통과

5. 비강측벽 ★

- ★ 상비도, 중비도, 하비도에 연결되는 부비동과 비루관을 나누어 쓰시오. (17,14,12,08)
- ★ 부비동 중에 중비도의 전상방으로 개구하는 부비동은? (11)
- ★ 중비도 전상부에는 (), 후부에는 ()이 개구한다. 알맞은 부비동을 적으시오. (15)

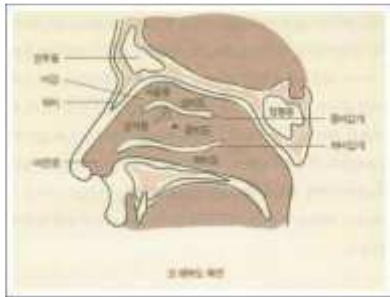
- 鼻甲介, 鼻道, 嗅裂

비갑개 비도 후열

- 비갑개(concha): 선반 또는 조개와 같은 용기가 하방을 향하여 비강내로 돌출.

비갑개의 돌출형 표면: 표면적을 넓힘으로써 외부의 찬·따뜻한 공기가 들어오면서 온도 및 습도 조절을 받아 폐로 이동하게끔 함!

- 1) 최상비갑개: 사골의 **흔적기관**. 약 60%에서 편측 혹은 양측
- 2) 상비갑개: 얇은 점막, 후각상피 존재. 상비도(중비갑개와의 사이)
 - 상비도: 전상방(후사골봉소 개구부), 후하방(접사함요; 접형동 개구)
- 3) 중비갑개: 타 비갑개에 비해 길고 큼. 갑개봉소(1~2개의 후사골봉소)
 - 중비도: 부비동과의 통로가 되므로 임상적으로 중요. 전상부(전두동의 **鼻前頭管**), 후부(상악동의 자연개구부와 이외 몇 개의 사골봉소). 중비갑개 절제 시 관찰됨
- 4) 하비갑개: 두꺼운 점막, 많은 정맥총을 포함한 특유한 해면체를 형성.
 - 하비도: 하비갑개 부착부의 전면 1/3부에서 비루관과 연



비도 : 비갑개와 비갑개 사이의 통로

축농증 ->상악동에 잘생김(->중비도가 따라서 중요)

cf) 해부학적 소견으로는 중비갑개가 사이즈가 크나, 임상에서 비염·축농증 등등에서 하비갑개가 부풀어 오름 따라서 하비갑개가 크게 보인다!

6. 비강점막

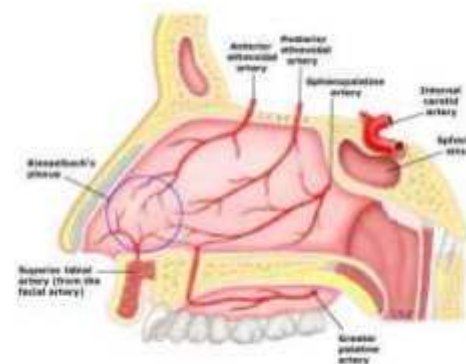
- 조직학적 소견

- 1) 호흡부: 嗅部를 제외한 비강의 대부분, 주로 비강의 하부. **담홍색, 선홍색의 위중층원주섬모상피 세포층**(섬모세포, 배상세포, 기저세포). 중하비갑개 일부 및 비종격 하부
- 2) 후각부: 비강전장, 비종격 상부, 상비갑개 내측면, 중비갑개 사골의 사판 등에 분포. 성인 약 2.5cm. 후각점막은 **황갈색의 섬모가 없는** 점막. 점액층, 후각상피세포층, 고유층으로 구분

7. 신경 및 혈관

- 1) 신경: 후각신경(비강 상부 1/3부위), 일반 감각(삼차신경의 안신경, 상악신경)
- 2) 혈관:

그림으로 이해하기



동맥

내경동맥 분지인 안동맥 : 전후사골동맥으로 감 외경 동맥 분지인 내악동맥: 접형구개동맥으로 주행. (사골동맥 : ethmoidal artery) (접형구개동맥 : sphenopalatine artery)

정맥

사골정맥에서 안정맥으로, 접형구개정맥에서 익구개 정맥총으로, 전안면정맥에서 내외측 경정맥으로 주행

비점막혈관의 중요한 특징

- 점막 밑에 많이 모인 정맥그물(혈관총)이 비점막의 해면체를 형성 → 비갑개가 쉽게 커졌다 줄었다 하게 됨
- 비염이 있을 때 하비갑개가 커지는 이유는 자체 점막비후 말고 혈관이 확장되면서 콧구멍을 막는 경우가 많음
- 비폐색 발생 시 로컬에서 긴 needle로 하비갑개가 부어있는 부분을 출혈시키는 경우가 많음 → 결과적으로는 붓기가 빠지면서 답답한 게 덜해지기는 함 (감염우려 주의)
- 전사골동맥, 후사골동맥, 접형구개동맥이 내려와서 만나는 **little area(Kiesselbach's plexus)**가 비출혈 다발 부위로 중요
- >따라서 알려지 비염의 경우 하비갑개쪽(해면체)를 살펴보아야함.

鼻漏

<역할>

1. 흡입한 공기의 온도와 습도 조절
 2. 비강내 작은 이물들을 포획, 용해시켜 점액섬모수송으로 이물질 제거
 3. IgA, lysozyme, 락토페린, 보체, 단백분해효소억제제, Vit C 같은 항산화제 등을 함유, 면역반응에 관여
- <구성>

1. 배상세포(goblet cell), 점막하 장액, 점액선에서 분비된 분비물
2. 혈관에서의 삼출물, 백혈구 ->따라서 면역반응이 있을 수 있음.
3. 점막세포의 부스러기
4. 눈물샘에서 분비된 눈물

3. 副鼻洞(paranasal sinuses)

- 각 부비동의 개구부 위치에 따라

- 1) 前群(전두동, 상악동, 전사골봉소근: **중비도**에 개구)
 - 2) 後群(접형동, 후사골봉소근: 최상비도, **상비도**에 개구) +하비도: 비루관 → 눈물이 빠져나온다.
- 부비동염 호발: **상악동 > 사골동 > 전두동 > 접형동** 부비동의 발육: 생후 12~14년에 거의 완성. 이후에도 약간 발육

부비동의 구조

1. 상악동: 15~20세 완성

- **부비동 중 가장 큰 동**
- **평균 용량 15cc**, 높이 3cm, 폭 2.5cm, 길이 3cm의 침단이 외측으로 향한 불규칙한 피라미드형
- 상벽(하안와신경관 통과), 하벽(상악골치조돌기 후면), 내벽(하비도, 중비도 대부분), 전벽(볼부위, 견치와)
- 하벽이 비강저보다 1cm 정도 낮고 齒根이 洞底에 밀접하여 치성 부비동염 유발
- **자연개구부**: 중비도의 사골누두 **중간**과 **연결**되어 배농에 부적당. 만성 염증 유발 원인

2. 사골동: 12~14세 완성

- 사골봉소가 편측 비강에 **평균 6~9개**
- 전부에 전두동, 후부에 접형동, 상벽은 두개저, 하벽은 비강에서 중비갑개를 형성
- **자연개구부**: 전사골봉소(중비도에 개구), 후사골봉소(상 및 최상비도에 개구)로 구분

3. 전두동: 20세경 완성

- 높이 1.5~2cm, 넓이 2~2.5cm, 평균 용량 **6~7cc**의 기저부를 위로하는 역삼각형
- 후벽으로 염증이 파급되면 **뇌막 또는 대뇌전두부분으로 파급(합병증 가능)**
- **자연개구부**: 하부의 전두동구나 비전두관에 의해 중비도 상방에 개구

4. 접형동: 12~15세 완성

- 두개골 중심에 위치. 1~1.5%에서 존재 안함 *점점 퇴행하는 구조
- 평균 용량 7.4cc, 6개벽 구성, **소아 접형동염은 아주 드뭄(방향이 아래를 향해 염증잘빠짐)**
- **자연개구부**: 접형동 저면의 접사함요(상비갑개 또는 최상비갑개의 내상방)와 연결

5. 부비동 점막·신경·혈관

- 점막: **비강 호흡부 점막의 연장**이나 전반적으로 얇음. 섬모운동이 각 부비동 자연개구부를 **향함**
- 신경: 지각신경(삼차신경 분지, 상악신경의 익구개신경)
- 동맥혈관: 상악동(내악동맥, 일부 안면동맥), 사골동(접형구개동맥, 전후 사골동맥), 전두동(상안와동맥, 상할차동맥), 접형동(상부는 안동맥의 후사골동분지, 하부는 내악동맥의 접형구개분지)

제 2장

코의 생리

비강의 생리기능:

1. 후각작용
2. 호흡작용(호흡기도의 역할, 흡기시 온도조절 및 가습작용, 자가정화작용, 방어작용)
3. 성음공명 작용

부비동의 생리기능:

1. 두개골을 가볍게
2. 공명으로 특색 있는 성음
3. 온도 및 습도조절
4. 공기 여과기능
5. 말소리, 씹을 때 나는 소리가 귀와 머리안으로 전달되는 것을 방지

1. 후각작용

- 嗅部(후부): 상비갑개 대부분, 중비갑개의 일부, 비중격 상부 1/3의 후각상피 부위로 비강 전체 표면적의 1.5%
- 신경: 후각신경 + 삼차, 설인, 미주 신경이 관여 **미각성 비염: 밥 먹을 때 미주신경이 자극되면 코 쪽 분비물이 늘어남 → 밥 먹을 때마다 코 풀어야 함
 - 후각상피층 구조
 - 1) 점액층(후각물질이 Bow-man 선에서 분비된 점액에 용해)
 - 2) 후각상피세포층(후각수용세포, 미세융모세포, 지지세포, 기저세포로 구성)
 - 3) 고유층(혈관, 결합조직세포, Bowman선 등 위치)
 - 후각의 인지과정
 - 1) 기체상태의 흡수성 후각자극분자가 비강에서 점액에 의해 친수성으로 변화
 - 2) 후각원결합단백과 결합하여 점액층내로 확산 또는 이동(대기보다 1만배 높은 농도)
 - 3) 섬모에 위치한 당단백인 수용체 단백질과 결합하여 후각수용세포의 활동전위를 일으킴
 - 기전 *입체화학설이 기본
 - 1) 입체화학설: 후소의 기본적인 7가지 냄새(에테르, 장뇌, 사향, 꽃, 박하, 부패한 냄새, 코를 찌르는 냄새)에 맞는 일정한 모양, 크기를 가진 수용체와 화학적 반응으로 후 자극 발생
 - 2) 변조설: 공기진동설. 냄새 분자가 진동운동을 일으켜 그 분자의 특성이 냄새로서 인지되어 후각

발생

- 3) 파동설: 광선 비슷한 energy의 파동(대류와 확산으로)이 후각신경 말단에 충돌

2. 호흡작용

1)호흡기도

- 흡기류: 주로 하비갑개와 상비갑개 사이를 통과, 일부만이 비강저부와 꼭대기를 지남
- 호기류: 심한 외류를 형성하며 비강 전체로 퍼짐. 후각점막의 후각 물질 제거, 비점막의 가온 및 가습 작용
- 안정시 흡기의 5~10%, 쿵쿵하는 경우 최고 20%정도가 후부를 통과
- 전비공에서 후비공까지 통과시간: 1/4초
- 비주기(nasal cycle): 양쪽 비강이 번갈아 가면서 비강내 기도저항이 증감하는 현상. 평균 4~12시간 주기로 반복

☞ 옆으로 누워서 잘 때 어느 한쪽에서만 자는 것이 편한 경우? (ex. 왠지 모르게 오른쪽으로 누워 자는 것보다 왼쪽으로 누워서 자는 것이 편한데, 이는 비주기 때문.)

2) 온도조절 및 습도조절

- 온도조절: 비강내에 필요한 熱은 해면점막동을 가진 비갑개나 비중격의 점막에서 조절. 40℃ 나 -40℃의 공기를 흡입하여도 비인강에서 31~37℃(평균 35℃)로 유지
- 습도조절: 비강을 지나면서 75~95% 상대습도로 가습. 점막하 고유층의 모세혈관, 점막하 분비액, 호기중의 수분, 비강으로 배출 되는 눈물, 구강점막 등에서 흡기시 습도조절을 위한 수분 공급. 비강내 습윤작용에 소비되는 수분의 양은 약 1L

3) 여과작용

- 흡기의 여과는 전비공의 鼻毛(직경 5~10μ의 미세 분말중 85% 제거)와 습한 비점막에 접촉되어 제거됨
- 먼지와 세균이 포함된 비점액은 섬모운동에 의해서 인두를 거쳐 咽에 들어가며 위액이 이물, 세균 등을 함께 파괴
- 비점액은 24시간 동안 점막 1cm 당 0.5~1ml가 생성

4) 자가정화 및 방어작용

- 점액층: 1시간에 2~3회씩 교환. pH 약 7의 중성(섬모 작용에 매우 중요). 점액은 후비강에서 인두를 거쳐 咽에서 위액과 함께 파괴

- 섬모운동: 부비동 점액층은 섬모운동으로 자연개구부를 향해 움직임
- 신경반사: 재채기(삼차신경, 뇌교, 연수, 제4뇌실 저부 호흡중추 자극, 횡격막신경 자극), **반사성 무호흡증**(미주신경 관련: 무호흡, 기관지 확장, 후두수축, 서맥 등 유발)

3. 성음공명작용

- 후두는 모음과 음조 음성(pitch voice)을 생성. 주된 주파수는 1000Hz 이하
- **성음**: 호기가 성대를 진동시켜서 발생되고 인두, 구강, 비강을 통해 공명작용을 하여 **특유한 음색**을 나타냄 >> 목소리가 사람마다 다르게 나옴!

- 비강의 공명을 통한 소리:

- 1) 비성 자음(ㅁ, ㄴ, ㅇ)
- 2) 비성 모음(불어, 폴란드어)
- 3) 비음화된 모음(nasalized vowel: 밥+만>밤만)

- 비성 자음, 모음을 발음할 때 인두강쪽으로 비강은 열려지고 자음을 발음할 때는 **연구개가 목구멍 부위에서 비강을 막는다.**

▶ 비음의 구성장애

- 1) 폐쇄성 비음: 비알레르기, 비후성 비염, 부비동염, 아데노이드 증식증 등으로 비폐색이 있을 때. **心火가 亢極하여 鼻閉되었거나 異物에 의하여 폐쇄되었을 때** 정확한 소리를 내지 못하는 상태
- 2) 개방성 비음: 구개파열, 연구개마비 때. **鼻의 외부적 손상 및 肺機能의 상실 상태**

4. 五臟六腑 및 經絡과 관계 - 참고

1. 五臟六腑와 관계

- 1) 鼻와 肺와 관계
- 2) 鼻와 心과 관계
- 3) 鼻와 脾胃 및 大腸과 관계
- 4) 鼻와 腦 및 膽과 관계
- 5) 鼻와 腎과 관계

2. 經絡과 關係

- 《靈樞·經脈篇》手陽明大腸經, 足陽明胃經, 手太陽小腸經, 足太陽膀胱經, 手少陽三焦經, 足少陽膽經, 手少陰心經, 督脈, 任脈, 陰蹻脈

제3장

코의 병인 및 병리

★ 비병 장부병리에서 실증, 열증, 급성은 (), (), () 와 관련이 있고, 허증, 한증, 만성은 (), (), () 와 관련이 있다. 빈칸에 들어갈 장부를 쓰시오. (15)

- 實證, 熱證의 急性 鼻病: 肺, 膽, 脾
- 虛證, 寒證의 慢性 鼻病: 脾, 肺, 腎

제 4장

진단 및 검사법

진단 (가.망진 / 나.聞진 / 다.問진 / 라.절진 / 마.시진,촉진 및 타진)

- 《素問·氣厥論》膽熱이 腦에 移하는 것을 辛頰이라 하여 鼻淵이 있어서 山根 혹은 下極에 매운 느낌이 일어나는 것
- 《醫學心悟》鼻頭가 青色을 띠면 腹中痛, 微黑色은 痰飲, 黃色은 濕熱, 白色은 氣虛, 赤色은 肺熱, 明亮은 無病이고 또한 鼻乾하면 邪熱이 陽明經의 肌肉內에 있는 것이며 오랫동안 경과되면 衄血이 나타남
- 《辨證錄》濁涕와 惡臭가 있는 것은 熱證, 清涕는 있으나 惡臭가 없으면 寒證, 清涕가 오랫동안 그치지 않는 것은 肺氣虛寒, 鼻塞不通하면서 濁涕稠粘한 것은 肺經에 熱鬱된 것

가.망진

1. 鼻와 氣의 관계

- 清竅: 天地의 清氣가 鼻를 통하여 인체에 들어오고 또 濁氣를 체외로 배출하기에 鼻는 氣가 출입하는 門戶

2. 鼻의 부위 및 구조

- 陽竅

안면은 陽의 位로 陽이 취합한 곳이고 鼻는 안면의 정중에 있기 때문에 陽中の 陽이며 清陽이 交會하는 곳이고 陽經이 鼻와 鼻傍을 순환하여 清陽의 氣가 출입하는 곳

- 《靈樞 五色篇》 鼻의 부위별 분류 :

- 關中(肺)
- 下極 부위인 頰과 山根(心)
- 鼻樑(肝)
- 鼻梁骨의 左側(膽)
- 鼻頭部位인 鼻準과 準頭와 面玉(脾)
- 兩側鼻翼(胃)

察色 ★

- 1) 青色: 鼻頭 青色(腹中痛; 冷하면 死), 鼻尖 青黃色(淋病). 肝氣上逆, 腎水虛寒
 - 2) 赤色: 赤(脾肺二經 實熱), 微赤(脾經虛熱), 鼻下 紅腫如瘡(腹中有蟲, 疳病)
 - 3) 黃色: 黃色(濕熱) 혹은 胸中有寒, 小便不利, 黃色 無澤(氣虛有痰), 黑黃色 明亮(瘀血)
 - 4) 白色: 白色(亡血, 氣虛血虧), 小兒 鼻白色(脾虛泄瀉, 乳食不化)
 - 5) 黑色: 鼻頭 微黑色(水氣內停), 黑色 焦枯(房勞過多)
- ▶ 청색 (복중통, 냉) / 적색 (열) / 황색 (습열) / 백색 (기허·혈허) / 흑색(死)

- 酒齋鼻(주사비): 딸기코. 못망울 끝이 울퉁불퉁함.

- 肺風瘡: 술 안 먹는 사람 red 코
- 鼻赤: 술 먹는 사람 red 코

- 肺風粉刺(폐풍분자) *여드름, 피지 등을 짜서 나오는 흰색 즙 등등..울체되기도 함

面鼻 紅赤色, 黍屑 혹은 疥瘡 같은 面皰, 귀파시 白色의 粉汁 유출, 오래되면 白屑, 肺經血熱 凝滯

- 動態(동태) 콧망울이 벌렁거림

- 1) 鼻煽: 鼻翼이 煽脹하는 動態. 호흡촉박, 곤란. 肺風, 肺絶
 - 2) 鼻翼이 微煽하고 咳嗽痰少, 胸悶氣粗, 舌紅脈數: 風寒, 風熱束肺, 肺火
 - 3) 鼻翼의 煽動이 빈번히 일어나면서 호흡급속한 것이 초기에 발생: 痰熱壅肺, 肺氣閉塞된 重證. 소아에서 다발
 - 4) 鼻翼의 煽動이 오래되면서 脈數疾虛: 肺腎氣虛로 難治
- ⇒ 응급질환 가능성

- 鼻息(비식)

- 1) 短氣: 호흡급속하면서 喘息과 비슷하게 肩不答하고 無痰鳴聲하는 것. 實證(痰飲結胸), 虛證(肺腎不足)
- 2) 上氣: 氣息急促이 喉間에 上逆하고 呼多吸短하는 것. 外感邪氣가 表에 울체, 痰飲內停으로 肺氣內壅
- 3) 少氣: 呼吸微弱 或 短, 聲低, 言語無力하여 氣少不足된 것. 肺腎氣虛
- 4) 息微: 氣息微弱하면서 呼吸의 接續이 단절되어 잘 이루어지지 않는 것. 肺

나 . 문진 (聞診)

- 여러가지 소리와 냄새의 변화로 진찰
 - 호흡시 鼻氣, 비강내 분비물 냄새, 氣息과 鼻音의 상태 관찰
- 1) 鼻鳴
 - 鼻音. 肺氣不利
 - 鼻鳴이 있으면서 鼻塞聲重: 外感風寒, 肺氣不利
 - 鼻鳴乾嘔, 汗出惡風, 脈數緩: 太陽中風證

2) 鼻臭

- 鼻竅內에 惡臭, 腥臭가 있으면서 鼻乾, 肌膜 枯固: 脾肺兩虛, 氣滯血瘀, 또는 邪毒이 鼻竅內의 肌膜에 壅滯되어 肌膜이 腐蝕

3) 噴嚏

☞ 분체가 많다? ➡ 알레르기 반응 우선 확인할 것

- 噴嚏 돌발적 聲音 高: 外邪侵襲
- 噴嚏 돌발적, 聲音 高, 혹은 한쪽 코만 지속적으로 막힘: 비강내 이물
- 噴嚏 빈번, 聲音 低微, 새벽마다 발작: 脾肺氣虛, 肺腎虛

다.문진(問診)

1)비색

傷風	초기 비색
肺氣虛寒, 脾氣虛弱	만성 비색
外感風寒	비색, 성음중탁, 비류청체
濕熱 혹은 氣滯血瘀	비색 지속 + 후각 감퇴 + 鼻痔가 병발
膽經火熱	간헐적 비색 + 비류탁체 + 악취, 두통
肺寒	비색 + 비류청체 + 鼻痒, 噴嚏
脾肺虛, 津液不足	鼻內 건조 + 鼻痛, 痂皮

2)비체

病因: 外感風寒, 肺衛虛弱, 肺氣虛寒, 腦冷

清涕	鼻飢, 噴嚏에서 발생. 주로 외감풍한, 폐기허한
濁涕 탁체	稠粘, 黃水 또는 膿血, 腥臭가 있는 鼻涕. 鼻淵, 腦漏에서 발생. 축농증 생각하기! 鼻涕 涕黃質稠(담열을 생각! / + 누런색, 양이 많다? = 습열 생각)(風熱表證, 膽經火熱), 涕黃濁量多(脾胃濕熱), 涕黃粘量少(肺熱燥盛), 黃綠色 膠結成塊, 惡臭(肺脾兩虛, 邪 毒鬱滯).

3)후각장애

風寒, 風熱 풍한 풍열	후각장애 병정 길지 않고 鼻塞, 鼻涕增多, 時有噴涕, 頭昏, 頭痛 發熱惡風 비색, 비체증다, 시유분체, 두혼
肺氣虛寒, 脾胃虛弱 폐기허한 비위허약	후각장애 때때로 輕重을 반복하면서 鼻塞鼻痒, 噴涕, 鼻流清涕 경증, 비색, 비양, 분체
비강이물	일측성 후각장애가 돌발적으로 생기고 鼻涕膿稠, 鼻氣臭減 비체농조 비기취예
대부분 氣滯血瘀, 혹은 痰濁凝聚 로 鼻內贅生物 기궤혈어 담탁응취	후각장애 오래되고 지속적 鼻塞, 頭昏痛 비색, 두혼통
肺脾虛損하여 鼻竅 기능 상실 폐비허손 비규	후각장애가 오래되고 鼻內 乾燥, 鼻涕가 膿痂를 結成 배출 이 어려우며 腥臭 비내건조 비체농가 결성

한의학적 접근 : 비색 등 코막힘이나 통로의 문제(전도성) / 통로문제가 없는 후각장애는.

한의학에서 잘 다루지 않는다. 그래서 한의학적인 후각장애는 거의 대부분 통로가 막혀 생기는 질환들

라. 절진 -> 맥진(큰의미x)

마. 시진, 촉진 및 타진

1. 시진

- 鼻背: 안비(saddle nose), 곡비, 사비, 종양으로 인한 외비기형 및 비류, 접형홍반
- 鼻前庭: 습진, 가피, 비절 등
- 鼻中隔: 코의 첨부를 무지로 들어올려 관찰. 성인 대부분 좌측 만곡
- 外鼻孔: 호흡곤란을 동반하는 질환(특히 폐렴)에서 흡기에서는 확대되고 호기에는 수축
- 납작코 - 부비동염 의심
- 비배가 구부러지거나 두드러짐 - 비폴립, 종양, 비중격만곡 의심
- 코끝이 빨갛고 변형 - 주사비, 비경화증

2. 촉진

- 비인강 종양, 아데노이드 구별(왼손 검지로 좌측 볼 점막을 齒列 사이로 눌러 입을 열도록 하고 오른손 검지로 비인강을 촉진)
- ▶ 직접 확인하기도 하나 시도하기는 어렵다(환자가 깨물수도..)

3. 타진 (부비동 질환)

- 좌우 눈썹 바로 밑과 광대뼈 밑을 각각 동시 압박하여 압통을 비교, 정상 (압통 무, 공명음 유) , 급성 전두동염 또는 상악동염 (압통 유, 유전두동 또는 상악동 주위 부종 유)

6. 鼻衄

★ 鼻衄의 병리기전을 허실로 나눠 쓰시오. (10)

1) 實證:

- 원인: 주로 肝火上逆, 胃火積盛
- 發熱, 無汗, 口鼻乾燥, 衄血量多, 不止, 鮮紅色, 脈浮數 혹은 大
- 正氣虛하면서 邪氣實한 逆證

2) 虛證

- 원인: 肝腎陰虛하여 虛火上炎, 脾不統血
- 面黃白, 身無熱, 간헐적 衄血量少, 淡紅色, 脈沈遲 혹은 細弱

2. 검사법 - 비경검사, (부비동의) 영상의학적 검사, 철조법, 통기검사, 후각검사

가. 비경검사

① 전비경검사

- 준비물: 이마반사경, 비경
- 비경을 왼손으로 잡고 비전정에 삽입하여 부드럽게 수직방향으로 조작
- 비익을 검지와 비경사이에 잡아서 검사자쪽으로 약간 당겨 관찰
- 정상 비점막: 분비액이 적당히 젖은 핑크색
- 정면상: 비전정, 하비도, 하비갑개, 비중격 하부, 비강저부 등을 관찰
- 두위를 30°후방 거상: 하비갑개 상부, 중비도, 중비갑개, 후열 등을 관찰

비염에서 거의 대부분 하비갑개에 병변이 나타난다.

+) 중비경검사

- 중비도에 위치한 부비동 자연공을 관찰
- 중비갑개, 중비도, 하비갑개, 비중격에 5% 코카인으로 마비시킨 후 긴 비경을 중비도에 넣고 중비갑개를 안쪽으로 누름

② 후비경검사

- 준비물: 광원, 머리반사경, 후두경, 설압자 등
- 환자 두위 수평, 설압자로 유곽유두 앞쪽으로 누르고 오른손으로 후두경을 경면을 위로 하여 가능하면 설압자 위에 놓음
- 후두경에 김서림 방지(·거울면)를 위해 가열 또는 알코올에 적심
- 후두경이 구개수의 옆을 지나 그 뒤쪽에 위치하고 후비공, 비중격, 상중하 비갑개와 비도, 이관인두부, 아데노이드, 비인강 후벽 및 천정 등 관찰



- 1: 상비갑개
- 2: 중비갑개
- 3: 하비갑개
- 4: 목젖
- 9: 아데노이드 *언급하신 part 만 정리함 (아데노이드 비대증의 경우 커져서 뒤쪽을 막아 버릴 수 있음)(비갑개 영역 가릴 수도)

③ 비내시경검사

- 비내시경 종류 (경직형을 보통 더 씀)

- 1) 경직형: 해상도가 좋고 다른 기구를 동시에 삽입하여 조작 가능
- 2) 굴곡형: 비인강과 인후부까지 동시에 관찰 가능

- 비강관찰 경로

- 1) 제1경로: 비강저를 따라 전진하여 전반적 비강내 상태 파악, 하비도에서는 비루관 입구, 이관, 비인두를 확인
- 2) 제2경로: 중비갑개와 하비갑개 사이로 전진하면서 중비도 하연 관찰 후 중비갑개의 내측으로 방향을 바꾸어 상비갑개, 접사함요, 접형동 자연공 등을 확인
- 3) 제3경로: 중비도 후방에 넣고 앞으로 빼면서 비강 측벽, 구상돌기, 사골포 등을 관찰

④ 비강소견

- 정상 비강소견

- 1) 하비갑개: 선홍색, 평활
- 2) 중비갑개: 하비갑개에 비해 색깔이 연하고 약간의 황색을 띠
- 3) 때로 측벽의 구름상 융기가 있어 중비갑개로 오인

- 이상 비강소견

- 1) 부비동 염증: 중비갑개 바깥쪽 변화. 급성(충혈), 만성(증식, 부종)
- 2) 알레르기: (보통 하비갑개쪽) 창백한 회색 종창, 장액성 분비물
- 3) 비염: 중비도나 중비갑개 점막의 평활 유연, 운동성있는 창백색의 광택이 있는 有莖性 점액종 보임
- 4) 위축성 비염: 비갑개 위축으로 비도는 넓고 비강후벽이 잘 보임

나. 부비동의 영상의학적 검사

- 부비동의 발육정도, 연부조직, 저류액의 유무, 종양의 유무 및 발육, 침윤상태와 골벽 이상의 유무 관찰에 중요

- 1) 전산화단층촬영(CT): 수술시 각 부비동과 주위 구조물의 정보, 종양 및 낭종의 진단과 병기 결정, 악성 종양의 감별
- 2) 자기공명영상(MRI): 종양의 연조직 침범정도와 두개내 파급을 평가. CT와 상호보완적
☞ 보통 MRI보다 CT를 확인하며, 좀 더 정밀하게 이용할 경우(ex. 수술고려) MRI와 CT를 상호 보완해서 사용
- 3) 부비동 초음파검사: 진단적 가치 떨어짐. 단 임신시 상악동에 관한 검사로 추천
- 4) x-ray 단순촬영

후두비부방향(water's view) ->턱을 약간든 자세	상악동의 전상부 및 전사골동부와 전두동의 저부 관찰
후두전두방향 (Caldwell's view) *정자세	전부비동, 특히 전두동과 안와 경계 및 사골동이 선명하게 관찰
좌우방향 (lateral view)	좌우측의 부비동이 중첩되어 부비동 질환의 진단상 가치는 적음
기저방향 (submentovertical view)	접형동을 잘 관찰

->후두비부, 후두전두방향을 주로 사용한다.



좌 : water's view ->원래 상악동에는 공기가 차있어 x-ray상 검은색만 보여야하는데 사진기준 오른쪽 상악동이 흰색으로 보임 ->농이 차있다.

우: caldwell's view

정면, 코를 쳐들고 찍어 코가 1자가 되게 만들고 직음 ->비중격이 올곧게 있는지 확인 가능.
비갑개의 크기 비교를 통해 어디가 더 막히는지 예측.

다. 철조법(광선투사 투시법) *요즘은 거의 안 씀!

★ 철조법 소견, 만성부비동염 증상 주고 의심부위, 질환명 (12,10,08)

- 주로 상악동, 전두동의 상태를 관찰
- 암실에서 철조등을 입에 물고 입을 다문 상태에서

상악동이 정상이면 협부가 불게 보이고 불그스름한 동공의 투과광선과 하안검 위치에서의 반월형 투과광선이 보임.

- 병변이 있으면 빛이 차단되어 검게 보임

라. 통기검사(비폐색검사)

- 통기장애는 주로 비폐색과 병발
 - 주관적 방법: 비강진찰, Visual Analog Scale(VAS: 아픈 정도를 0~10으로 설정, 내 상태는 몇?)
 - 객관적 방법
1. 해부학적 관점: 음향비강통기도검사(코구멍에서 나오는 바람이 어느 정도인지 기계를 통해 체크)
 2. 생리학적 관점: 비습도측정법, 최대호기유량 측정법, 비강통기도검사

마. 후각검사

▶ 후각기능검사(olfactometry)

- 1) 부탄올 후각역치검사: 각 비공에 N-butyl 알코올 가장 약한 농도부터 노출시켜 환자가 인지하는 최저 역치 측정
- 2) UP-SIT(후각확인검사): 40 가지 향료가 담긴 미세 캡슐을 연필 등으로 긁어 냄새를 맡고 4 지선다형으로 표시. 정답 20 점 이하(후각상실), 20 ~34 점(후각저하), 34 점이상(정상) (부탄올 후각역치검사 발달 ver.)
- 3) KVSS II(Korean Version of Sniffin' Sticks test II): 부탄올 및 한국인 익숙한 16개 냄새를 이용

▶ 후각탈출(anosmia)의 종류

호흡성	비염, 부비동염, 비용, 비종양 등으로 후소가 후부까지 못 감
진성	사골동염에서 후부의 후세포 기능장애나 파괴로 발생
중추성	외상으로 후신경 및 후구가 손상, 대뇌피질 중 후두측두구, 해마구인 후각중추의 기능적 장애, 종양 등

후각탈출의 종류

★ 후각탈출(anosmia)은 호흡성, 진성, 중추성의 3가지로 분류된다. 각각을 설명하시오. (13)

★ 후각과민증을 일으키는 원인 질환을 쓰시오. (12,00)

- 후각과민 : 감기, 월경, 임신, 신경쇠약, 히스테리등, 중추신경계의 이상흥분, . 惡臭嗅覺, 錯嗅, 幻嗅覺

바. 구음검사

1. 개방성 비성

- 발생시 비강으로 공기 배출량이 증가하여 발생
- 연구개의 기능저하로 구개인두 폐쇄가 부적절한 경우, 구개열과 같은 선천적 이상, 외상으로 인한 구개천공, 아데노이드 제거술이나 코골이 수술 후 합병증, 위축성 비염 등

2. 폐쇄성 비성

- 비강 혹은 비인강에 폐쇄가 있어 비인강으로 빠져나가는 공기량이 적어져 발생. “m”, “n”의 자음이 “b”와 같이 발음
- 1) 전부: 비후성 비염, 비용 등
- 2) 후부: 아데노이드 증식, 후비공 폐쇄, 후비공 비용이나 비인강 종양 등

제 5장

비질환의 일반증상

1. 비색

- 호발부위: 비전정, 비판, 비강 상부, 하비갑개 전방부, 비갑개 후방부 및 후비공

▶ 원인에 따라

1. 해부학적 구조 이상: 비중격 만곡증, 천공, 비갑개 비후, 안비, 후비공 폐쇄 등
2. 과다증식, 종양: 아데노이드 증식증, 비용종, 양성 및 악성종양 등
3. 각종 육아종병: 부비동염, 각종 비염, 비중격 혈종, 농양, 이물, 결핵

★ 일측성 비폐색과 농성 비루를 특징으로 하는 질환을 3가지 이상 쓰시오. (15,14,13,12,11,10)

★ 일측성의 비폐색, 농성비루, 악취가 있을 경우 의심할 수 있는 질환을 3가지 이상 쓰시오. (18,17)

- 일측성 비폐색시: 비강 이물, 후비공 폐쇄, 비강과 부비동의 양성 혹 악성 종양, 치성 상악동염, 진균성 부비동염 의심
- 증상: 성인(코골이), 유소아(구호흡, 상악골 발육장애, 아데노이드 얼굴, 鳩胸, 漏斗胸. 상기도 감염, 이관 카타르, 중이염 등 유발), 학동기 및 청소년(鼻性 주의집중불능증)

☞ 한의학에서 鼻塞의 임상징후 _ 변증의 요약이라고 생각하기

- ① 초기(風熱, 風寒): 콧물양 증가, 후각장애, 비점막 충혈, 身熱, 惡風, 舌苔白, 脈浮 / 鼻塞, 鼻痒, 嚏, 鼻淵 빈번, 콧물이 물처럼 흐름, 비점막 회백색
- ② 진행(痰熱, 瘀血): 발작적 嚏, 濁涕, 口苦心煩, 舌紅苔黃, 脈滑 / 鼻塞이 오래되어 콧물이 나오지 못하고 정체, 두통, 현훈, 비점막 暗紅色
- ③ 만성(肺氣虛弱, 脾胃虛弱): 鼻塞 오래되어 호전과 악화를 반복 / 食少, 便溏, 舌淡, 脈弱
- ④ 鼻茸(濕熱痰): 비색 오래되어 지속적으로 막히고 때로 가증, 鼻茸

2. 비루

▶ 비루의 양상에 따라

1. 수양성: 급성 비염 초기, 알레르기 비염 등
2. 점액성 혹 점액농성: 감염. 급성 비염의 2차 감염기, 만성 감염성 비염, 부비동염
3. 한쪽 농성 비루: 치성 부비동염, 비강 혹 부비동의 악성 종양, 유소아의 비강 이물

4. 혈성: 악성 종양, Wegener 육아종

5. 악취성: 악성 종양(상악암), 치성 부비동염, 비강 이물, 위축성 비염

★ 악성종양을 의심하게 하는 소견 3 가지: 한쪽 농성 비루 / 혈성/ 악취성

▶ 점액분비 감소

1. 쇼그렌 증후군, 위축성 비염, 건조성 비염 등.
2. 전신 질환: 당뇨병, 신장염, 동맥경화증, 소아 장내 기생충

▶ 후비루 (교수님 ㄷ 잘 봐두기)

1. 주로 비강 및 부비동 질환
2. 위산역류나 비인강질환
3. 혈성 후비루: 비인강암

▶ 뇌척수액비루: 사고 수술관련 외상성(96%). 약간 씹쓸하거나 짠맛으로 표현

<비루의 감별>

장액성	급성 비염(초기), 알레르기성 비염
점액성	급성 비염(말기), 만성 비염, 만성 부비동염
농성	만성 부비동염, 비강 이물, 결핵
출혈성	비 디프테리아, 상악암, 건성 전비염, 선천성 비매독
악취성	상악암, 치성 상악동염, 비강 이물, 취비증
분비 부족	급성 비염(초기), 급성 감염, 당뇨, 신장염, 동맥경화증, 기생충 감염

3. 후각장애

▶ 종류

- 후각소실: 완전 소실
- 후각감퇴: 부분 소실
- 착후각: 존재하는 냄새를 다르게 느낌
- 환후각: 존재하지 않는 물질의 냄새를 느낌(정신분열증, 강박관념, 히스테리, 약물중독 등)
- 후각과민: 신경쇠약, 임신, 월경, 히스테리, 전두엽 종양, 애디슨병 등

▶ 원인: 대부분 상기도 감염, 비강 혹 부비동 질환, 두부 외상 등

▶ 발생기전에 따라

1. 전도성: 비강내 기류의 차단으로 후각점막에 후각원이 전달되지 못하여 발생, 가역적
2. 감각신경성: 후각점막의 손상이나 후각신경계의 이상으로 발생. 비가역적
3. 혼합성: 전도성과 감각신경성이 혼합되어 발생

4.분체

- 주로 알레르기 비염, 혈관운동성 비염 등에서 흔히 발생
- 찬 공기, 이물, 악취 등과 같이 온도변화나 물리적 화학적 자극으로도 유발
- 이외 외이도의 자극, 피부의 냉자극, ***밝은 빛**, 심인성 원인에서도 발생
- *태양을 직접 쳐다보면 재채기가 나오는 경우!

5.비출혈

- ★ **비강 출혈은 부위에 따라 전방부 출혈과 후방부 출혈로 나뉘는데 그 둘을 구분하라. (17,13)**
- ★ **비출혈 부위에 따른 분류 중 비강 후반부의 출혈에 대해 쓰시오(15,11)**

	전방부(전비공) 출혈	후방부(후비공) 출혈
부위	대부분 비중격 전방의 Little 영역 (Kiesselbach's plexus 부위)	하비도 후방 Woodruff 영역
발생 원인	국소적 외상, 과로시 호발	동맥경화 혹은 고혈압이 있는 고연령층에서 다발
양상	비점막 건조 시 미량, 출혈 발생	지혈이 안 되고 출혈량 많음
처치	- 얼음물로 비세척 - 멈추지 않으면 패킹 • 바세린 거즈 + 삼칠근 분말 • 앞에서부터 차곡차곡 거즈를 쌓음	- 응급치료: 혈압강하제 or 패킹 1) L 튜브를 코에 넣어서목젖 뒤에서 입으로 뽑음 2) 편도패킹한 것을 달아 다시 코쪽으로 빼내 편도패킹이 입에 걸리게 함 3) 실을 밖으로 뽑고 전비공 패킹을 실시 4) 남은 곳에 편도패킹을 앞에 달아 묶음

6.두통

< 한의학적 鼻源性 頭痛 4가지 > ※ pg.10 비색의 한의학적 임상징후와 비색

- 1) 外邪犯肺: 감기 초기에 머리 아픔. 비색(풍한·풍열)과 연결지어 이해!
眩暈頭痛 초기. 鼻涕 量多, 비점막 충혈, 鼻甲介 腫大, 畏寒發熱, 苔白, 脈浮
- 2) 痰熱移於腦: 太陽穴 근처까지 두통, 鼻塞濁涕, 口苦咽乾, 鼻甲介 腫大, 舌紅苔黃, 脈弦數
담열=축농증
- 3) 肺氣虛寒: 은은하게 반복되는 두통, 鼻塞, 후각장애, 비강점막 淡白色, 鼻甲介 腫大, 風寒邪를 만나면 더 심해지고, 舌淡苔白, 脈弱
- 4) 瘀血阻滯: 찌르는 듯한 두통, 후각장애, 지속적 비색, 鼻黏膜 暗紅色, 鼻甲介가 뽕나무열매처럼 변형

▶ 부비동염의 급성기

1. 상악동염: 협부 동통, 압통. 치아나 이마로 방산통
 2. 사골동염: 비근점 부위와 안구 후방에 통증
 3. 접형동염: 눈의 후방에 심한 통증, 측두부와 두정부로 방산통
 4. 전두동염: 전두동 부위에 국한. 두정부로 방산통, 박동성 두통
- 비성 두통: 비중격 만곡증, 각종 비염으로 하비갑개 비후 등

7.비성

1) 개방성 비성

- 발생시 비강으로 공기 배출량이 증가하여 발생
- 연구개의 기능저하로 구개인두 폐쇄가 부적절한 경우, 구개열과 같은 선천적 이상, 외상으로 인한 구개천공, 아데노이드 제거술이나 코골이 수술 후 합병증 등

2) 폐쇄성 비성

- 비강 혹은 비인강에 폐쇄가 있어 비인강으로 빠져나가는 공기량이 적어져 발생
- > 1) 전부 폐쇄성 비성: 비후성 비염, 비염 등
- > 2) 후부 폐쇄성 비성: 아데노이드 증식, 후비공 폐쇄, 후비공 비염이나 비인강 종양 등

8. 연관통

- 비갑개와 부비동에서 발생하는 동통 : 삼차신경에 의한 연관통 유발.

1. 중비갑개 앞쪽 자극: 삼차신경 1지. 전두부 및 눈의 내외측, 코의 외측부에 연관통
2. 중비갑개 뒤쪽 자극: 삼차신경 2지. 협부 및 측두부에 연관통

9. 안면통

- 종양, 신경통, 부비동염, 혈관 폐색 등과 관련
- 특히 부비동염의 경우 각각의 부비동염에 따른 특징적인 통증 유발

10. 비성 안구합병증

- 부비동과 밀접
- 만성 부비동염, 비강 및 부비동의 종양은 안검부종, 안구운동마비 유발
- 합병증: 안와주위염, 안와봉와직염, 골막하농양, 안와농양, 해면정맥동혈전 등으로 안검종창, 결막

부종, 안구돌출, 안근마비, 시력감퇴 등 발생

- 비루관을 통해 비강내 염증이 쉽게 결막염, 누낭염 유발

11. 신경증상

- 비폐색, 비루 등으로 우울감, 무관심, 주의력 산만, 기억력 감퇴 발생

- 특히 학생에서 鼻性 주의집중 불능증 발생

제 6 장

치료 및 조호법

《景岳全書》

- 鼻病은 크게 外感風寒과 內火上炎으로 발생. 外感은 辛散, 內熱은 清涼으로 치료
- 항상 鼻塞은 火, 돌연히 鼻塞은 風寒이 많다.

《醫學入門》

- 鼻病 초기에는 疏風降火하는데

① 外感風寒일 경우에는 溫散으로

② 風熱內鬱, 肝熱生風, 外感이 오래되어서 熱로 변하거나 內因 또는 음식에 상했거나 鼻塞이나 鼻涕가 계속 유출될 경우에는 清金降火한다.

1. 치료법 (창이자산 말고는 크게 언급 안하심)

가. 내치법

1) 疏風宣肺

- 鼻塞, 聲重, 후각 감퇴, 不聞香臭, 鼻涕, 惡寒 發熱, 頭痛, 舌苔薄白, 脈浮 - 葱豉湯

(1) 風寒: 鼻涕清涕, 鼻竇內가 蒼白, 淡紅 浮腫 - 荊防敗毒散

(2) 風熱: 清涕 혹은 濁涕가 고대로 발생, 鼻竇內가 紅腫 - 銀翹散

2) 芳香通竅

*대부분의 콧병은 코막힘을 동반함! 창이자산(창이자, 세신, 백지, 박하)을 살펴보는 게 좋아 보임!

- 甚한 鼻塞, 嗅覺消失, 頭重, 稠黃 粘稠 濁涕, 鼻癰, 鼻甲介 腫脹, 舌苔薄白, 脈弦 - 蒼耳子散

☞ 창이자산: 鼻病에서 추천드리자면 본인의 처방에 창이자산을 가미, 합방(비색 등이 동반되었을 시) 본인이 결정한 변증에 따른 처방에 창이자산을 합방해서 써라!

3) 清熱解毒

- 鼻腔內 癰疽瘡癤, 鼻尖, 鼻翼, 鼻前庭의 發赤腫痛, 口苦咽乾, 鼻痛, 濁涕, 鼻竇內 紅腫疼痛, 化膿, 或 鼻衄 - 銀花解毒湯, 黃連解毒湯
화농 독 비 역 은 화 해 독 탕 황 연 해 독 탕

4) 排膿除涕

- 膿濁涕 黃色量多, 鼻塞, 鼻粘膜 腫脹, 或 清涕量多, 頭暈頭脹, 胸悶納呆, 四肢無力, 舌苔膩, 脈弦
농 탁 체 황 색 량 다 비 색 비 점 막 종 창 청 체 량 다 두 혼 두 팽 흉 먼 납 대 사 처 무 력 맥 현
온 담 탕 곡 향 정 기 산

5) 理氣活血

- 鼻塞不通, 鼻粘膜 腫脹하고 표면 굴곡으로 편평하지 않고 桑椹 모양을 띠며 紫赤色, 頭暈頭
痛, 心煩易怒, 脈弦數 - 丹梔逍遙散, 杞菊丸加味
비 색 불 통 비 점 막 종 창 상 심 자 적 색 두 혼 두
통 심 번 의 노 맥 현 수 단 단 치 소 요 산 기 곡 환 가 미

6) 補肺固表

- 鼻塞鼻痒, 噴嚏頻發, 鼻流清涕, 鼻粘膜 灰白色, 身疲乏力, 舌淡, 脈弱 - 玉屏風散, 四君子湯

7) 涼血止血

- 코피, 코에서 나오는 공기가 뜨겁고, 혹은 鼻乾, 疼痛, 鼻粘膜 紅赤糜爛, 舌紅, 脈數有力
- 十炭散

8) 補脾益氣

- 鼻涕清稀 色白量多, 鼻塞頭暈, 嗅覺減退, 鼻甲腫大, 深紅色, 少氣懶言, 四肢倦怠, 舌淡, 苔白, 脈弱
- 參苓白朮散

9) 滋補肺腎

- 鼻塞, 鼻孔乾燥, 灼熱感, 疼痛, 鼻涕膿稠, 嗅覺減退, 腥臭, 粘膜萎縮, 乾燥少津, 舌紅, 脈細
- 百合固金湯

나. 외치법

1) 滴鼻法

- 疏風宣肺, 芳香通竅하는 煎湯液 또는 藥液을 點鼻하는 방법
- 鼻甲腫大, 嗅覺障礙, 頭暈頭痛, 혹 鼻塞, 鼻涕 증가, 鼻粘膜 紅腫, 혹 鼻涕膿稠, 結痂, 膿痂를 만드는 鼻病
- 鼻流清涕, 鼻塞, 噴嚏, 鼻瘡, 鼻疔 등에 사용
- 藥物: 辛夷花, 薄荷, 荊芥, 蒼耳子 / 芝麻油, 蜂蜜 등

2) 蒸氣吸入法

- 芳香避穢, 宣肺利竅하는 약물의 증기를 코로 흡입하거나, 가슴기로 흡입하는 방법
- 鼻竇室塞, 嗅覺減退, 頭暈頭痛, 혹 코에서 나쁜 냄새가 나서 맡기 어려울 정도이고, 鼻涕 膿稠한 鼻病
- 藥物: 薄荷, 藿香, 白芷 (방향성 약재)

3) 吹藥法

- 疏風宣肺, 祛痰利竅하는 藥物의 極細末을 鼻竇內에 吹入하는 방법
- 鼻塞, 嗅覺障礙, 鼻涕清稀, 量多한 鼻病
- 外感風熱, 風寒, 鼻塞, 鼻衄 / 牙關緊急, 開合不利
- 藥物: 薄荷, 藿香, 細辛, 牙皂, 防風 ㉠ 瓜蒂散도 자주 쓴다.

4) 塞鼻法

- 清熱瀉火, 涼血止血하는 藥末을 면봉 또는 솜으로 싸서 鼻竇內에 插入하는 방법
- 비강출혈 / 오래된 鼻塞, 不聞香臭, 鼻瘻肉에도 사용
- 藥物: 生地黃, 牡丹皮, 炒蒲黃

5) 外敷法

- 清熱瀉火, 消腫解毒하는 藥物을 물로 糊狀으로 만들어 환처에 敷貼하는 방법
- 外鼻 癰疽瘡癤 / 酒渣鼻, 鼻瘻肉, 鼻竇內 潰瘍, 糜爛에도 사용
- 藥物: 黃蓮膏, 金黃散

다. 침구요법

- 1) 頭項部: 百會, 上星, 印堂, 迎香, 禾膠, 素膠, 人中, 風府, 風池
- 2) 軀幹部: 大椎, 風門, 關元 / 曲池, 列缺, 合谷 / 足三里, 太衝
- 3) 奇穴: 印堂, 太陽, 鼻通
- 4) 耳鍼: 內鼻, 腎上腺, 額, 內分泌, 肺穴點
- 5) 藥針: 禾膠, 迎香, 鼻通, 印堂, 太陽, 眉衝, 內庭, 足三里, 風池, 熱症(황련해독탕, 소염, BUM), 虛症, 寒症(녹용, 자하거)
- 6) 灸: 直接灸, 隔薑灸, 縣灸. 清涕나 濁涕(上星), 不聞香臭(迎香, 上星, 合谷)

㉠ 도인치료

- 비색, 비제, 채재기, 빈발 시 사용
- ① 拇指(엄지)를 食指(검지) 외측에 있도록 하고 양손으로 주먹을 쥐는데
- ② 양엄지의 배측을 鼻梁의 양측에 대고 양 鼻根에서 迎香혈까지 왕복 3국부에서 열감이 날 때까지 마찰
- ③ 찬죽에서 태양혈을 향해서 국부에서 열감이 날 때까지 왕복한 후
- ④ 태양혈 30번 가볍게 누르기
- ⑤ 매일 2~3회

라. 기타요법

1) 안마법

- 鼻塞, 頭痛頭暈, 嗅覺障礙, 噴嚏, 清涕 등에 多用
- 상용 穴位: 迎香, 太陽, 攢竹, 風池 등
- 방법: 먼저 양쪽 魚際穴을 비벼서 열을 내고 양 손의 엄지손가락으로 風池穴을 안마. 매회 5~10분, 매일 2~3회 시행

2) 도인법

- 신체운동(몸통 仰俯와 수족 屈伸 등), 호흡기식의 자아조절(深호흡, 淺호흡, 意念호흡 등), 자아 안마와 서로 결합된 疏通經絡, 氣血流暢, 自我保健 효능이 있는 일종의 치료법

예방법 ->알아서 하라함. (할거없다고)